

FRACTURAS MANDIBULARES

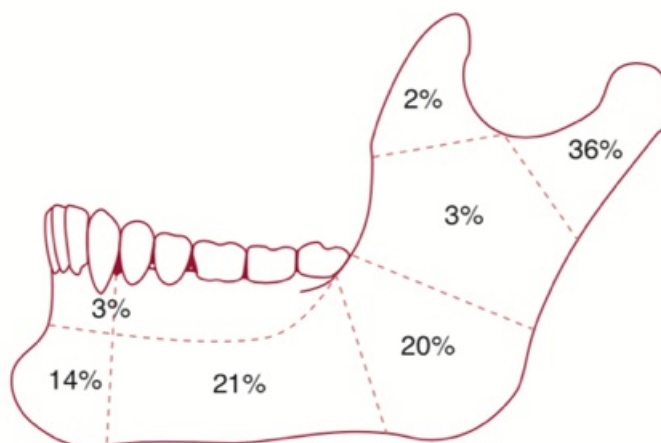
Samuel Espías Alonso, Pablo Montes Fernández-Micheltorena, Eduardo Monteserín Martínez, Marta Peña Barreno, Raúl Antúnez-Conde, Gema Arenas de Frutos, Elena Salomé Bullejos Martínez.

INTRODUCCIÓN

Las fracturas mandibulares constituyen las segundas en frecuencia dentro del macizo facial tras las fracturas nasales. Su etiología varía en función de la población estudiada. En nuestro medio, las agresiones y los accidentes de tráfico constituyen las causas más habituales.

Las fracturas mandibulares suelen localizarse en áreas de menor resistencia (región subcondílea, brechas edéntulas, regiones con piezas dentales retenidas...). Pueden producirse por mecanismo directo o indirecto. Los impactos en la región submental, por ejemplo, pueden presentar focos de fractura a nivel subcondílea, como mecanismo indirecto, al ser esta región un área de menor resistencia.

Existen numerosas clasificaciones en función de distintos criterios: según el trazo de fractura (horizontal o vertical), de su comunicación o no con el medio externo (abiertas o cerradas), la relación entre fragmentos óseos (desplazada, no desplazada, conminuta) y/o según su localización a nivel de arco mandibular (sínfisis, cuerpo, ángulo, rama, coronoides o cóndilo).



DIAGNÓSTICO

Existen distintos signos sugestivos de fractura mandibular. Cambios en el contorno facial, simetría o forma de la arcada dentaria pueden orientar el diagnóstico.

La alteración en la oclusión es uno de los hallazgos más comunes, si bien es necesario descartar que no sea debida deformidades dentofaciales, alteraciones previas en la ATM o lesiones dentoalveolares. La desviación de la mandíbula con la apertura es indicativa de una fractura condílea. En una fractura condílea unilateral, la mandíbula se desvía hacia el lado de la fractura, presentando una mordida abierta en el lado sano. Las fracturas condíleas bilaterales pueden presentarse con una mordida abierta anterior sin desviación de la mandíbula necesariamente.

Pese a que la causa más común de apertura limitada es el dolor y la contractura refleja de la musculatura masticatoria, asociados con el traumatismo, también se produce una disminución de la apertura cuando existe una fractura deprimida del arco cigomático, al colisionar este sobre el proceso coronoide de la mandíbula.

Es importante explorar la sensibilidad de la región labial y mentoniana, puesto que los pacientes con fracturas desplazadas a nivel de ángulo y cuerpo mandibular pueden referir disestesias o hipoestesias a dicho nivel por lesión del nervio alvéolo dentario inferior.

Las laceraciones gingivales pueden estar asociadas con fracturas dentales o alveolares, pero también pueden ser indicativas de una fractura mandibular subyacente. La equimosis y/o hematoma sublingual también es un signo altamente consistente de fractura mandibular.

Otros signos que podemos encontrar durante la exploración son, escalones óseos, crepitación y movilidad de los segmentos óseos, o de las piezas dentales involucradas en el foco de fractura.

Pruebas complementarias

En situaciones clínicas donde los mecanismos de lesión o exploración física sugieren una fractura, se necesitan estudios radiográficos para confirmar el diagnóstico y planificar el tratamiento posterior.

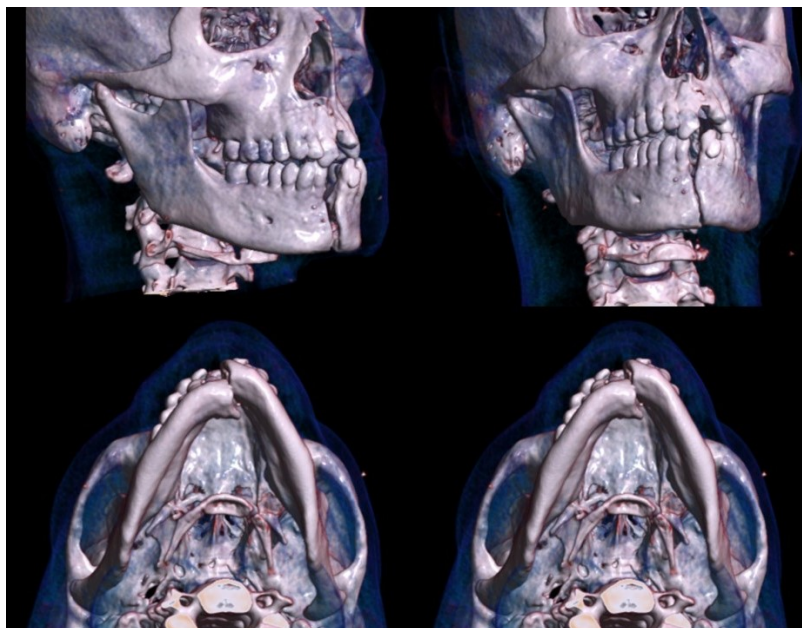
- **La ortopantomografía.** En relación a la radiografía simple, la ortopantomografía constituye la prueba fundamental. Permite obtener una visualización satisfactoria de todas las regiones de la mandíbula (cóndilo, rama, cuerpo y sínfisis). Aporta datos sobre la continuidad de las corticales, trazos de fractura y/o desplazamiento de fragmentos. Así mismo, resulta de utilidad para examinar el estado de la dentición existente y su relación con el foco de fractura.



Fractura de mandíbula

Las proyecciones antero-posterior y de perfil mandibulares no nos aportan imágenes fiables de las lesiones mandibulares, por lo que no se deben solicitar pues carecen de valor diagnóstico.

- **La tomografía computarizada.** La tomografía computarizada sin contraste se puede considerar la prueba radiológica de elección, sobre todo en centros que no dispongan de ortopantomografía. Nos permite obtener cortes en distintos planos, proporcionando una situación exacta del tipo de fractura, de la integridad de ambas corticales, siendo especialmente útil en las fracturas condíleas.



TRATAMIENTO

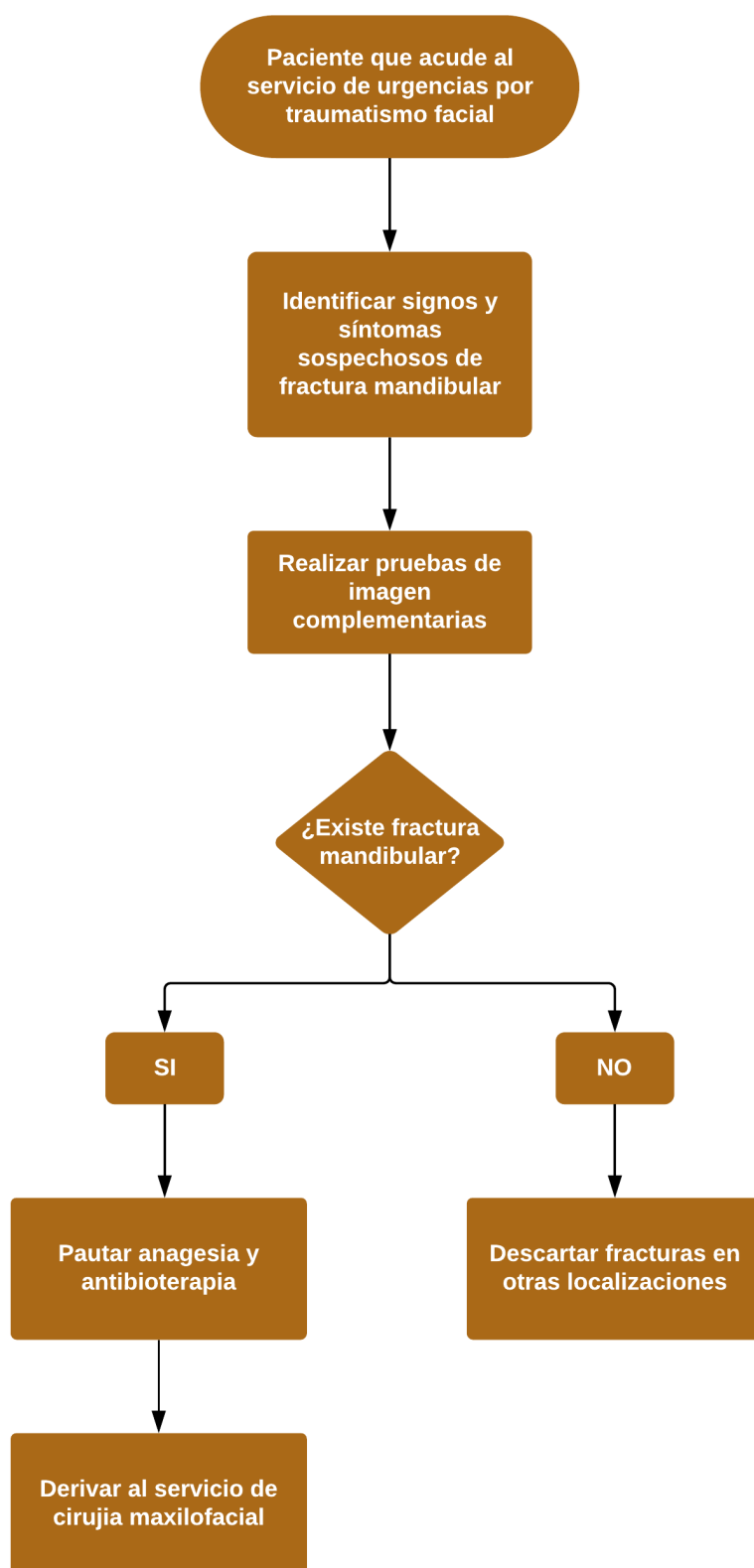
Las fracturas mandibulares pueden presentarse de forma aislada, o asociadas a otras fracturas faciales principalmente en el contexto del paciente politraumatizado. En estos casos, se priorizará el tratamiento de las patologías que supongan un compromiso vital según el protocolo ABCDE.

Se debe verificar y asegurar la permeabilidad de la vía aérea, explorando minuciosamente la cavidad oral para detectar la presencia de cuerpos extraños, piezas dentales avulsionadas, esquirlas óseas que puedan comprometer una correcta ventilación. Si existen heridas asociadas, serán desbridadas, limpiadas y si es necesario, suturadas.

Una vez que se ha confirmado la existencia de una fractura mandibular, se prescribirá medicación, principalmente por vía intravenosa, que incluirá:

- **Cobertura antibiótica.** De elección amoxicilina-clavulánico. En alérgicos a la penicilina, la alternativa podría ser la clindamicina sola o asociada a otro antibiótico.
- **Analgesia** mediante antiinflamatorios no esteroideos y/o según escala analgésica de la OMS.
- **Corticoesteroides.** Podría además asociarse una pauta con corticoesteroides (metilprednisolona:urbason) para reducir la inflamación asociada, .

Posteriormente, se derivará al paciente al Servicio de Cirugía Maxilofacial.

Protocolo de actuación en urgencias

BIBLIOGRAFÍA

- García Marín F, Ochandiano Caicoya S. Cirugía oral. Carlos Navarro Vila. 2ª ed. Madrid: Aran; 2009.
- Ward Booth P, Eppley BL, Schmelzeisen R. Traumatismos Maxilofaciales y reconstrucción facial estética. Peter Ward Booth. 1ª ed. Madrid: Elsevier; 2005.
- Kademani D, Tiwana PS. Atlas de Cirugía Oral y Maxilofacial. 1ª ed. Amolca; 2017.